O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-2: Oftalmologik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarda hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda oftalmologik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarni parvarish qilish xususiyatlari, ko‘z kasalliklarining asosiy simptomlari, hamshiralik muolajalari hamda ko‘rish o‘tkirligini jadvallar asosida tekshirish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Oftalmologik bemorlarda hamshiralik ishining xususiyatlari va asosiy simptomlar
2. Ko‘z kasalliklarini davolashda hamshiralik muolajalari, operatsiyadan oldingi va keyingi parvarish
3. Ko‘rish o‘tkirligini jadvallar asosida tekshirish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Oftalmologik bemorlarni davolashda hamshiralik ishining xususiyatlarini aytib beradi.
- Ko‘z kasalliklarining asosiy simptomlarini va ularda hamshira harakatlarini tushuntiradi.
- Tomchi dori tomizish, malham qo‘yish va ko‘zni yuvish qoidalarini sanab beradi.
- Ko‘rish o‘tkirligini jadvallar yordamida tekshirish tartibini tushuntiradi.

Tayanch so‘zlar

hamshiralik jarayoni, fotofobiya, ko‘z yoshlanishi, instillyatsiya, kon’yunktiva bo‘shlig‘i, aseptika, deontologiya, ko‘rish o‘tkirligi, Sivtsev–Golovin jadvali, Orlova jadvali.

1. Oftalmologik bemorlarda hamshiralik ishining xususiyatlari va asosiy simptomlar

Ko‘rish a’zosi inson atrof-muhit to‘g‘risidagi ma’lumotlarning asosiy qismini qabul qiladigan sezgi a’zosidir. Ko‘rishning pasayishi yoki yo‘qolishi bemor uchun og‘ir ruhiy va ijtimoiy sinov hisoblanadi: u o‘qish, ishlash, harakatlanish va o‘ziga xizmat qilish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli oftalmologiya bo‘limi hamshirasining vazifasi faqat shifokor buyurgan muolajalarni bajarish bilan cheklanmaydi. U bemorga ruhiy dalda beradi, uning xavfsizligini ta’minlaydi va ko‘rish funksiyasini imkon qadar tiklashga ko‘maklashadi.

Hamshiralik ishi hamshiralik jarayoni asosida tashkil etiladi. Bu jarayon besh bosqichdan iborat: bemorni tekshirish (ma’lumot to‘plash), hamshiralik tashxisini qo‘yish (bemor muammolarini aniqlash), parvarish rejasini tuzish, rejani amalga oshirish va natijani baholash. Oftalmologik bemorda ko‘p uchraydigan muammolar: ko‘zdagi og‘riq, ko‘rishning pasayishi, yorug‘likdan qo‘rqish, ko‘z yoshlanishi, yiqilish xavfi, operatsiyadan qo‘rquv, infeksiya xavfi va kasallik haqida bilim yetishmasligi. Hamshira har bir muammo uchun aniq maqsad qo‘yib, unga erishish yo‘llarini belgilaydi.

Ko‘z kasalliklarining asosiy simptomlari

Bemor bilan suhbatda hamshira shikoyatlarning qachon boshlanganini, bir yoki ikki ko‘zda ekanini, oldin shunday holat bo‘lgan-bo‘lmaganini va qanday dorilar qo‘llanganini aniqlaydi. Ko‘p uchraydigan simptomlar quyidagilardir:

- Ko‘rish o‘tkirligining pasayishi. To‘satdan yoki asta-sekin rivojlanishi mumkin; katarakta, glaukoma, to‘r parda ko‘chishi va ko‘ruv nervi kasalliklarida kuzatiladi. To‘satdan ko‘rish yo‘qolishi shoshilinch holat bo‘lib, bemor darhol shifokorga yo‘naltiriladi.
- Og‘riq. Yot jism sezgisi, achishish, sanchiq yoki bosib turuvchi og‘riq bo‘lishi mumkin. Boshning bir tomoniga tarqaluvchi kuchli og‘riq, ko‘ngil aynishi va ko‘rish xiralashishi glaukoma xurujidan darak beradi.
- Fotofobiya (yorug‘likdan qo‘rqish), ko‘z yoshlanishi va qovoqlarning qisilishi (blefarospazm) birgalikda “shox parda sindromi” deyiladi. Ular keratit, shox parda shikasti va iridotsiklitda uchraydi.
- Ko‘zning qizarishi. Kon’yunktival qizarish (o‘tish burmalari tomon kuchayadi) kon’yunktivitga, perikorneal qizarish (limb atrofida ko‘kimtir-qizil halqa) esa shox parda va rangdor parda yallig‘lanishiga xos.
- Ajralma. Shilimshiq, yiringli yoki suvsimon bo‘lishi mumkin. Yiringli ajralmada ertalab kipriklar yopishib qoladi.
- Ko‘z oldida qora nuqtalar, chaqnashlar, “parda” ko‘rinishi to‘r parda va shishasimon tana kasalliklariga xos; bu holatda ham bemorni tezda shifokorga yuborish kerak.

Tashqi ko‘rikda hamshira ikki ko‘zni taqqoslaydi: qovoqlarning shishi va qizarishi, kipriklar holati, ko‘z tirqishining kengligi, ajralma mavjudligi, ko‘z

olmasining holati va qorachiqlarning bir xilligi qayd etiladi. Ko‘rish o‘tkirligi har bir murojaatda tekshiriladi, chunki aynan shu ko‘rsatkich kasallik og‘irligini va davolash natijasini baholashga yordam beradi. Olingan ma’lumotlar tibbiy hujjatga aniq yoziladi. Bemorning umumiy kasalliklari (qandli diabet, gipertoniya, allergiya), iste’mol qilayotgan dorilari va kasbi ham so‘raladi, chunki ular kasallik sababi va davolash rejasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.



Ko‘zning qizarishi: bemor ko‘rigida qizarish xarakteri aniqlanadi

Parvarish va xavfsizlik xususiyatlari

Fotofobiyasi bor bemorlar uchun palatada quyosh nurini to‘suvchi pardalar ishlatiladi, ko‘chada quyoshdan himoya ko‘zoynagi tavsiya etiladi. Ko‘rishi keskin pasaygan yoki ko‘zi bog‘langan bemorning xavfsizligi alohida nazoratda bo‘ladi: palatadagi mebel joyi o‘zgartirilmaydi, bemorga xona, hojatxona va chaqiruv tugmasining joyi tushuntiriladi, yo‘lak va pol toza hamda quruq saqlanadi. Bemor bilan muloqotda hamshira avval o‘zini tanishtiradi, har bir harakatini ovoz chiqarib aytadi va bemorni ogohlantirmasdan unga tegmaydi. Bu qoidalar yiqilish va shikastlanishning oldini oladi, bemorning hamshiraga ishonchini oshiradi.

Ko‘z infeksiyalari qo‘l, sochiq, pipetka va asboblar orqali oson yuqadi. Shuning uchun har bir bemordan keyin qo‘l yuviladi, har bir bemorga alohida steril tampon va dori ishlatiladi. Yuqumli kon’yunktivitli bemorlar uchun alohida sochiq va tomchi dori ajratiladi, tekshiruv asboblari dezinfeksiya qilinadi. Ko‘zga qo‘yiladigan dorilarning yaroqlilik muddati va ochilgan sanasi nazorat qilinadi.

2. Ko‘z kasalliklarini davolashda hamshiralik muolajalari, operatsiyadan oldingi va keyingi parvarish

Ko‘z kasalliklarini davolash mahalliy va umumiy usullardan iborat. Mahalliy davo tomchi dorilar, malhamlar, ko‘zni yuvish, kon’yunktiva ostiga va ko‘z atrofiga in’yeksiyalarni o‘z ichiga oladi. Umumiy davoda antibiotiklar, sulfanilamidlar, yallig‘lanishga qarshi va vitamin preparatlari ishlatiladi. Fizioterapiya (UVCh, elektroforez) ham keng qo‘llaniladi. Hamshira barcha muolajalarni aseptika va

antiseptika qoidalariga qat’iy rioya qilgan holda bajaradi, muolajadan oldin dori nomi, foizi, yaroqlilik muddati va qaysi ko‘zga buyurilganini tekshiradi.

Ko‘zga tomchi dori tomizish (instillyatsiya)

Jihozlar: steril pipetka yoki dori flakoni, steril doka tamponlar, antiseptik, buyurilgan dori

1. Qo‘lni yuving va antiseptik bilan ishlov bering; bemorga muolajani tushuntiring.
2. Dori nomi, foizi, muddati va ko‘zni (OD, OS) shifokor varaqasi bilan solishtiring.
3. Bemorning boshini biroz orqaga egdiring, yuqoriga qarashini so‘rang.
4. Pastki qovoqni steril tampon bilan pastga torting.
5. Pipetka uchini kipriklarga tekkizmasdan, pastki qovoq xaltachasiga (ichki burchakka yaqinroq) 1–2 tomchi dori tomizing.
6. Bemordan ko‘zni yengil yumishni so‘rang.
7. Dorining umumiy qonga so‘rilishini kamaytirish uchun ko‘zning ichki burchagini 1–2 daqiqa tampon bilan bosib turing.
8. Ortiqcha dorini toza tampon bilan arting, qo‘lni yuving va muolajani qayd eting.

Qovoq orqasiga malham qo‘yish

Jihozlar: ko‘z malhami, steril shisha tayoqcha yoki tyubik, steril tampon

1. Pastki qovoqni pastga torting va bemorga yuqoriga qarashni ayting.
2. Malhamni tayoqcha yoki tyubik uchidan pastki qovoq ichiga tashqi burchakdan ichki burchakka qarab qo‘ying.
3. Bemorga ko‘zini yumib, qovoq ustidan yengil uqalashni ayting.
4. Ortiqcha malhamni tampon bilan arting.

Ko‘zni yuvish yiringli ajralma bo‘lganda, ko‘zga kimyoviy modda tushganda va muolajalar oldidan bajariladi. Yuvish steril furatsilin eritmasi yoki boshqa antiseptik bilan, ko‘zning ichki burchagidan tashqi burchagiga qarab amalga oshiriladi. Bemorning boshi yuvilayotgan ko‘z tomonga biroz egiltiriladi, shunda suyuqlik sog‘lom ko‘zga oqmaydi. Ikki ko‘z yuvilganda har biriga alohida tampon va idish ishlatiladi: avval sog‘lom, keyin kasal ko‘z tozalanadi.

Ko‘z bog‘lamlari va dorilarni saqlash

Bir ko‘zga qo‘yiladigan bog‘lam monokulyar, ikki ko‘zga qo‘yiladigan bog‘lam binokulyar bog‘lam deyiladi. Bog‘lam ko‘zni tashqi ta’sirlardan himoya qiladi, tinchlik yaratadi va dori ta’sirini kuchaytiradi. Ammo yiringli ajralmali kon’yunktivitda bog‘lam qo‘yilmaydi, chunki ko‘z pirpiratish to‘xtab, ajralma to‘planadi va mikroblar tez ko‘payadi. Ko‘z tomchilari ochilgandan keyin odatda bir oy ichida ishlatiladi, yorug‘likdan himoyalangan joyda saqlanadi, ayrim dorilar sovutgichda turadi. Atropin kabi kuchli ta’sir etuvchi dorilar alohida qizil belgili idishlarda saqlanadi va hisobga olinadi. Bemorga uyda dori tomizish tartibi, tomchilar orasida kamida 5 daqiqa kutish va flakon uchini ko‘zga tekkizmaslik o‘rgatiladi.

Operatsiyadan oldingi tayyorgarlik

Hamshira bemorga operatsiya haqida umumiy tushuncha beradi, uning qo‘rquvini kamaytiradi (psixoprofilaktika). Shifokor ko‘rsatmasi bilan operatsiyadan bir necha kun oldin antibakterial tomchilar boshlanadi, tahlillar to‘planadi, qon bosimi va qandni nazorat qilish ta’minlanadi. Operatsiya kuni bemor yuvinadi, kipriklar qisqartiriladi (buyurilgan bo‘lsa), kon’yunktiva bo‘shlig‘i yuviladi, qorachiqni kengaytiruvchi yoki boshqa buyurilgan tomchilar tomiziladi. Bemorda yo‘tal, burun oqishi, tish og‘rig‘i, yuzda yiringli toshma bo‘lsa, hamshira bu haqda albatta shifokorga xabar beradi.

Operatsiyadan keyingi parvarish

Operatsiyadan keyingi dastlabki soatlarda bemor yotoq tartibida bo‘ladi. Unga operatsiya qilingan tomonga yonboshlab yotish mumkin emas: faqat chalqancha yoki sog‘lom tomonga yotadi. Keskin harakat, og‘ir yuk ko‘tarish, engashish, kuchli yo‘talish va aksirish taqiqlanadi, chunki ular ko‘z ichi bosimini oshiradi va choklarga salbiy ta’sir qiladi. Ich qotishining oldini olish uchun yengil hazm bo‘ladigan ovqat tavsiya etiladi. Yuz yuvilganda ko‘zga suv kirmasligi, ko‘zni qo‘l bilan ishqalamaslik tushuntiriladi. Hamshira bog‘lam holatini, og‘riqni, tana haroratini kuzatadi; kuchli og‘riq, ko‘ngil aynishi, ko‘rishning keskin yomonlashuvi yoki bog‘lamning qonashi haqida darhol shifokorga xabar beradi.



Ko‘z operatsiyasi: hamshira bemorni tayyorlash va parvarishda ishtirok etadi

3. Ko‘rish o‘tkirligini jadvallar asosida tekshirish

Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash oftalmologik tekshiruvning birinchi va eng muhim bosqichidir. Bu tekshiruvni hamshira mustaqil bajaradi, natija kasallikni aniqlash, davolash samarasini baholash va tibbiy ekspertiza uchun zarur. Tekshiruv maxsus jadvallar yordamida o‘tkaziladi.

Kattalar uchun eng ko‘p ishlatiladigan jadval Sivtsev–Golovin jadvalidir. U 12 qatordan iborat bo‘lib, harflar yuqoridan pastga kichrayib boradi. Har bir qator chap tomonida shu qatorni normal ko‘z o‘qiy oladigan masofa (D, metrda), o‘ng tomonida esa 5 m dan o‘qilganda ko‘rish o‘tkirligi (V) ko‘rsatilgan. Yuqori qator normal ko‘z bilan 50 m dan, o‘ninchi qator esa 5 m dan ko‘riladi. Golovin jadvalida

harflar o‘rniga turli tomonga ochilgan halqalar (Landolt halqalari) ishlatiladi; bu savodsiz odamlar va boshqa tilda gaplashuvchilar uchun qulay.

Bolalarni tekshirish uchun rasmli Orlova jadvali qo‘llaniladi: unda tanish rasmlar (qo‘ziqorin, mashina, qush va boshqalar) kichrayib boradi. Bola rasmlarni tanish uchun tekshiruvdan oldin ular bilan yaqin masofada tanishtiriladi. Sog‘lom bolalarda ko‘rish o‘tkirligi yosh bilan oshib boradi va 5–7 yoshga kelib 1,0 ga yetadi.

Tekshirish uchun zarur sharoitlar

- Bemor bilan jadval orasidagi masofa 5 m bo‘lishi kerak; xona kichik bo‘lsa, ko‘zgu yordamida masofa uzaytiriladi.
- Jadval bir tekis yoritiladi. Buning uchun Rot apparati ishlatiladi, yoritilganlik taxminan 700 lyuks.
- Jadvalning 10-qatori bemor ko‘zi balandligida bo‘lishi kerak.
- Bemor ko‘zoynak taqib yursa, avval ko‘zoynaksiz, keyin ko‘zoynak bilan tekshiriladi va ikkala natija yoziladi.
- Har bir ko‘z alohida tekshiriladi. Yopib turilgan ko‘z bosilmaydi, chunki bosim keyinchalik ko‘rishni vaqtincha pasaytiradi.

Ko‘rish o‘tkirligini tekshirish algoritmi

Jihozlar: Sivtsev–Golovin jadvali, Rot apparati, ko‘rsatgich, ko‘z to‘sig‘i (shitok), dezinfeksiya vositasi

1. Bemorga tekshiruv maqsadini tushuntiring va jadvaldan 5 m masofaga qulay o‘tqazing.
2. Rot apparatini yoqing.
3. Chap ko‘zni to‘siq bilan bosmasdan yopishni so‘rang, avval o‘ng ko‘zni tekshiring.
4. Ko‘rsatgich bilan yuqori qatordan boshlab harflarni ko‘rsating. Ko‘rsatgich belgiga tegmasin, har bir belgi uchun 2–3 soniya bering.
5. Bemor xatosiz o‘qigan eng pastki qatorni aniqlang (0,3–0,6 qatorlarda bitta, 0,7–1,0 qatorlarda ikkita xato mumkin).
6. Xuddi shu tartibda chap ko‘zni tekshiring.
7. Natijani hujjatga yozing: Visus OD = 1,0; Visus OS = 0,8.
8. To‘siq va ko‘rsatgichni dezinfeksiya qiling, qo‘lni yuving.

Past ko‘rishda tekshirish

Agar bemor 5 m dan birinchi qatorni o‘qiy olmasa, u jadvalga 1 m dan yaqinlashtirib boriladi. Birinchi qatorni o‘qigan masofa d aniqlanadi va Snellen formulasi bilan hisoblanadi: V = d / D. Bu yerda D = 50 m. Masalan, bemor birinchi qatorni 3 m dan o‘qisa, V = 3/50 = 0,06. Agar bemor jadvalga yaqin kelganda ham o‘qiy olmasa, oq fonda barmoqlarni sanash tekshiriladi: masalan, 30 sm dan sanasa, ko‘rish o‘tkirligi 0,005 deb yoziladi. Barmoqlarni sanay olmasa, yuz oldida qo‘l harakatini ko‘rishi aniqlanadi. Keyin qorong‘i xonada ko‘zgu bilan yorug‘lik

tushirib tekshiriladi: yorug‘likni sezish va uning yo‘nalishini to‘g‘ri aniqlash. Yorug‘likni umuman sezmasa, ko‘rish o‘tkirligi nolga teng.

Ko‘rish o‘tkirligi yoshga, yoritilganlikka va bemorning umumiy holatiga bog‘liq. Charchagan, stress holatidagi yoki yaqinda ko‘z tomchisi olgan bemorda natija pastroq chiqishi mumkin. Shu sababli qorachiqni kengaytiruvchi tomchilar tomizilishidan oldin ko‘rish o‘tkirligi tekshiriladi. Takroriy tekshiruvlar imkon qadar bir xil sharoitda o‘tkaziladi, shunda natijalarni solishtirish mumkin bo‘ladi. Maktab va bog‘chalardagi profilaktik ko‘riklarda hamshira ko‘rishi past bolalarni aniqlab, ota-onalarga xabar beradi va oftalmolog ko‘rigiga yo‘naltiradi. Haydovchilik guvohnomasi olish, harbiy xizmat va ayrim kasblarga tanlovda ham ko‘rish o‘tkirligi albatta tekshiriladi.

Tekshiruv natijasi noto‘g‘ri bo‘lishiga sabab bo‘ladigan xatolar: masofaning noto‘g‘ri olinishi, jadvalning yetarli yoritilmasligi, ko‘zning qattiq bosilishi, bemorning ko‘z qisib qarashi, jadvalni yodlab olgani, shoshilish. Hamshira bu xatolarning oldini olishi, bemorni ko‘zini qismasdan qarashga undashi va qatorlarni tartibsiz ko‘rsatishi kerak. Ko‘rish o‘tkirligi 1,0 dan past bo‘lgan barcha bemorlar shifokor ko‘rigiga yo‘naltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.